Tratamiento no farmacológico del dolor oncológico

Dolor crónico: dolor oncológico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Prehabilitación
4. Terapia psicológica
5. Terapia física
6. Yoga
7. Masaje
8. Medios físicos
   Calor
   Crioterapia
9. Efectos del Reiki respecto al dolor oncológico
10. Musicoterapia
11. Acupuntura
12. Conclusiones
13. Bibliografía

Objetivos

Conocer el tratamiento no farmacológico del dolor oncológico.

Introducción

El Observatorio Europeo del Cáncer (ECO-OEC) estima que la incidencia de cáncer presenta una tendencia en aumento; alcanzando cifras en 2018 de 683,5 casos por cada 100 000 habitantes y suponiendo la muerte de más de 294,3 por cada 100 000 pacientes (1).

Uno de los síntomas más frecuentes en el paciente oncológico es el dolor, con una prevalencia del 47 al 54 % según el tipo de tumor, localización, extensión y progresión de la enfermedad, alcanzando el 90 % en cáncer avanzado. Es un síntoma que perdura incluso una vez erradicada la enfermedad y supone una pérdida de la calidad de vida del paciente. Por eso, el manejo del dolor oncológico debe ser fundamental tanto durante, como después de la enfermedad (2).

Durante toda la historia natural del cáncer, entre el 50 % de los pacientes presentan dolor, alcanzando al 75 % en situación de enfermedad avanzada y terminal. Además, del total de estos enfermos, en torno a un 25 - 30 % presentarán un dolor de alta severidad, mientras que un 60 % sufrirá más de un tipo de dolor y un 30 % padecerá 3 o más tipos diferentes de dolor. Casi un 30 % de los enfermos oncológicos no reciben un tratamiento analgésico adecuado (1).

Según las estimaciones actuales, 5,7 millones de personas tienen acceso limitado a los analgésicos opioides en América Latina y el Caribe, con niveles moderados de consumo (1 - 10 mg de equivalente de morfina per cápita por año) en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, México, Costa Rica y Uruguay, Guatemala, Honduras y Bolivia; en los últimos tres, los niveles se han mantenido particularmente bajos, lo que indica que el consumo medio se encuentra muy por debajo de los rangos a escala internacional (3). Ello sugiere que el manejo del dolor es inadecuado en gran parte de la población latinoamericana (3).

Según las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Oncología Médica, las localizaciones anatómicas más frecuentes de dolor, señaladas por pacientes con cáncer, son: columna vertebral (36 %), abdomen (27 %), tórax (24 %), miembros inferiores (22 %), cabeza, cuello y región pélvica (17 %), miembros superiores (11 %) y región perianal (7 %) (3).

El dolor impacta en todos los aspectos de la vida de una persona, no sólo interfiriendo con su actividad, sino también con sus emociones, motivaciones, relaciones interpersonales y calidad de vida en general. Existe suficiente evidencia que demuestra la relación entre supervivencia y control del dolor; de allí la importancia de controlar el dolor a través de intervenciones efectivas (4).

Tradicionalmente, en el paciente con cáncer coexiste el dolor agudo y crónico. Se distinguen los siguientes tipos de dolores físicos (2 – 4):

- **Somático o nociceptivo:** por estimulación de nociceptores cutáneos y de tejidos profundos como el hueso. Es un dolor constante y bien localizado. Son ejemplos de este tipo de dolor las metástasis óseas y el dolor de las incisiones postquirúrgicas (2 – 4).
- **Visceral:** como resultante de la infiltración, compresión, distensión o estiramiento de vísceras torácicas y abdominales por afectación primaria o metastásica. Es un dolor mal localizado, y a menudo referido a la piel. Puede asociarse a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudoración, sobre todo el dolor agudo (2 – 4).
- **Neuropático:** por afectación de los nervios periféricos, plexos o médula espinal, a causa de infiltración, compresión tumoral, o secundario a la quimioterapia, radioterapia o cirugía. Es un dolor paroxístico, quemante, eléctrico, sordo, urente o lancinante; acompañado de parestesias, disestesias, hipo e hiperestesia, así como de alteraciones motoras, sensitivas y del Sistema Nervioso Autónomo (2 – 4).
- **Mixto:** con características de dolor nociceptivo y neuropático, es el tipo de dolor más frecuente en los pacientes oncológicos (2 – 4).

La evaluación exhaustiva del dolor es esencial para asegurar un manejo adecuado, se debe realizar desde el momento del diagnóstico, con seguimiento a intervalos regulares y cuando se inicie un nuevo tratamiento (4).

En la medida de lo posible, la intensidad del dolor debe ser cuantificada por el paciente usando una escala numérica de 0 a 10, o una escala pictórica. La escala de dolor con caras puede ser útil en pacientes que presenten dificultades con otras escalas, como niños o adultos mayores y pacientes que no hablen español o con otras barreras de comunicación (4).

La estrategia farmacológica más utilizada para su tratamiento, aprobada por numerosas guías clínicas como la del National Comprehensive Cancer Network (NCCN), European Society for Medical Oncology (ESMO) o Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), es la escalera analgésica de la OMS publicada en Cancer Pain Relief en 1986 y actualizada en 1996. La OMS recoge cómo se debe llevar a cabo la evaluación y el tratamiento del dolor en los pacientes con cáncer, basándose en una escala secuencial de tres niveles de fármacos que va desde fármacos con baja potencia hasta fármacos muy potentes, en función de la intensidad del dolor (2 – 4).

Las metas en el manejo del dolor involucran lograr una disminución del dolor en un 30 al 50 % del inicial, prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento, maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente (4).

En realidad, para lograrlo es necesario reconocer que el dolor es multidimensional y no sólo afecta la esfera física, también la sociológica, psicológica y cultural. Las personas con dolor sufren, así como su familia, cuidadores e incluso profesionales tratantes (4, 5).

No debemos de olvidar que la rehabilitación es un aspecto esencial en la atención integral de las personas con cáncer como parte del cuidado, para disminuir las posibles secuelas físicas y psicológicas, aliviar el dolor, favorecer la reinserción-reintegración a las actividades laborales, sociales y familiares de los pacientes, vivir con dignidad (6, 7).

Por este motivo, se considera de suma importancia establecer estrategias que ayuden a mitigar los efectos adversos de las terapias en las vidas de los pacientes. Es así como surge el concepto de prehabilitación, o fase de pretratamiento, el cual propone alcanzar una adecuada preparación física y emocional previo al inicio de la fase terapéutica, con el objetivo de facilitar la recuperación, disminuyendo la utilización de servicios de salud (5).

Existen nuevas alternativas en el manejo no farmacológico, como el ejercicio físico, el yoga, la terapia cognitivo-conductual y la terapia basada en atención plena o mindfulness (8).

Prehabilitación

Actualmente la prehabilitación incorpora el concepto de mitigación o prevención del deterioro, la cual se puede aplicar a diferentes patologías, entre estas al cáncer (5).

La prehabilitación se define como un proceso que mejora la capacidad funcional y mental de un individuo con el fin de amortiguar los posibles efectos nocivos ante un factor significativamente estresante. Utilizando previo al tratamiento, las intervenciones necesarias para preparar al paciente física y emocionalmente, y que así pueda sobrellevar con mayor éxito los impactos inmediatos y a largo plazo ocasionados por el procedimiento necesario para tratar su patología (5).

Se ha demostrado que el acondicionamiento psicológico y físico en los pacientes, antepuesto a la cirugía, ha mejorado las reservas tanto mentales como corporales para enfrentar de mejor manera la etapa postquirúrgica (5).

La fase de pre tratamiento se establece en el periodo de tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento e incluye asesorías psicológicas y físicas que en principio determinarán el nivel funcional basal, ayudarán a identificar discapacidades y a definir estrategias para intervenciones físicas y psicológicas (5).

Es muy importante enfatizar la diferencia entre prehabilitación y recuperación postquirúrgica mejorada Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), esta última incluye elementos dirigidos a reducir el estrés perioperatorio, mantener una adecuada función fisiológica postquirúrgica y acelerar la recuperación luego de una cirugía (5).

Mientras que la prehabilitación, como se explicó anteriormente, se enfoca en la mejora de la capacidad funcional y mental del paciente para enfrentar de manera más exitosa los tratamientos venideros (5).

Terapia psicológica

La depresión y la ansiedad son diagnósticos encontrados con frecuencia en pacientes con cáncer. Diversos estudios han logrado determinar que los trastornos psicológicos impactan negativamente tanto en el control del dolor, cicatrización de heridas como en el aumento en las estancias hospitalarias, de la misma forma que se asocian con disminución en la respuesta inmune y con aumento de la mortalidad (5, 9, 10).

Debido a esto se han propuesto varias terapias psicológicas para tratar estos padecimientos, entre ellas se encuentran (5, 9, 10):

- Las estrategias de resolución de problemas y afrontamiento
- Consejería
- Técnicas de relajación, entre otras

Tradicionalmente estas intervenciones se han aplicado luego del tratamiento del cáncer, no obstante, ahora se reconoce que el periodo perioperatorio es muy perturbador para estos enfermos, en este sentido, cada vez existe evidencia más robusta que apoya la psicoterapia previa a la intervención quirúrgica, ya que ha demostrado tener un impacto positivo en la recuperación post operatoria mejorando la calidad de vida de los pacientes (5, 9, 10).

Algunos estudios han establecido que los tratamientos psicológicos previos a una cirugía logran disminuir los niveles de cortisol en el cuerpo humano y mejoran el proceso de cicatrización luego de una intervención abdominal (5, 9, 10).

Existe evidencia que apoya la terapia psicológica durante la fase de pretratamiento, ya que:

- Mejora la calidad de vida
- Disminuye la ansiedad y depresión
- Mejora el control del dolor
- Reduce la fatiga
- Mejora el funcionamiento físico, la habilidad para deambular y para realizar tareas de rehabilitación (5, 9, 10)

Técnicas de relajación

Parás *et al.*, estableció una práctica guiada mediante la relajación de Jacobson, *(figura 1)* que se llevó a cabo en habitaciones cómodamente amuebladas con sillones, cojines, luces suaves y un ambiente tranquilo en general. Todos los participantes tomaban analgésicos (5, 9, 10).

Tras la práctica y el seguimiento se observó que hubo cambios durante las cuatro semanas en el estado de ansiedad, relajación, concentración y dominio de la técnica en comparación con el inicio de la intervención. También se muestra la reducción del consumo de psicotrópicos y analgésicos durante las cuatro semanas de seguimiento (5, 9, 10).

Durante todo el proceso de seguimiento, más del 95 % de los pacientes habían practicado la técnica en el hogar. Más del 97 % de los pacientes informaron cada semana que la relajación los había ayudado a controlar los síntomas de ansiedad (5, 9, 10).

Entre el 21,01 % y el 22,69 % de los pacientes con dolor informaron una mejoría en el control del dolor. Los resultados evidenciaron que la técnica de relajación ayudó a reducir el consumo de psicotrópicos y analgésicos. También contribuyó a la mejoría y la aparición de cambios positivos en todos los parámetros evaluados (5, 9, 10).

Psicoeducación y terapias cognitivas de comportamiento:

Los pacientes de cáncer pasan por incontables situaciones nuevas, que llevan consigo un alto nivel de estrés a causa de las preocupaciones, temores, dolores y síntomas depresivos asociados (11).

El tipo de intervención psicológica más utilizada y estudiada con pacientes de cáncer se encuadraría dentro de las terapias cognitivo - conductuales, también conocidas como terapias de "segunda generación" (11).

Su objetivo principal consiste en modificar directamente el comportamiento (cogniciones, emociones y conducta observable), habiendo resultado ser especialmente eficaces cuando el paciente presenta un estilo de afrontamiento pasivo/evitativo o de negación (11).

Mejoran la visión subjetiva que el paciente tiene de sus síntomas físicos y emocionales. Se busca implementar técnicas de conservación de energía y manejo de actividades: ayudan al paciente a economizar sus recursos físicos haciendo sólo lo más importante y planeando su tiempo de forma que incluya actividades lúdicas e intervalos de descanso apropiados (5, 9, 10).

Sin embargo, la mejoría alcanzada por los pacientes en la reducción de los niveles sintomáticos tras finalizar la intervención se desvanece con el paso del tiempo. Como alternativa a ello, en las últimas dos décadas están emergiendo con fuerza las terapias de "tercera generación", cuyo principal exponente sería la terapia de aceptación y compromiso (11).

Mindfulness

Terapia de tercera generación. El mindfulness se fundamenta en terapia de aceptación y compromiso (ACT), lo que permite mayor adaptabilidad y flexibilidad. El impacto en dolor se establece en que, al tener mayor aceptación, se verá mejor funcionamiento a nivel psicológico, físico y social *(figura 2)* (8).

Existen dos principales modalidades de intervención:

a) Mindfulness con regímenes intensivos y una duración mínima de ocho semanas, basada en la reducción de estrés.

b) Terapia cognitiva basada en mindfulness (8).

A diferencia de lo propuesto por las terapias de "segunda generación", la ACT busca que el paciente tome distancia de sus eventos privados aversivos (pensamientos, emociones y sensaciones molestas), aceptándolos, para que así pueda reorientar su actuación a lo que considere importante en su vida, de acuerdo con sus valores (direcciones con significado) (11).

Estas actuaciones, que tienen en común promover el distanciamiento de los fenómenos mentales (defusión cognitiva) y suprimir los intentos de control emocional y cognitivo, han mostrado una eficacia superior a las terapias cognitivo-conductuales en el tratamiento de las alteraciones psicológicas de los pacientes de cáncer, así como en el mantenimiento de la mejoría en el largo plazo (11).

No obstante, las investigaciones y estudios realizados sobre la aplicación de la ACT en pacientes con cáncer son escasas en comparación con el de otras investigaciones realizadas desde las aproximaciones terapéuticas de "primera" o "segunda generación", que llevan más años en la escena psicológica (11).

Se realizó una revisión sistemática sobre los estudios empíricos publicados en revistas de lengua inglesa y española, que permita establecer el estado actual de la cuestión. La búsqueda de las publicaciones que reunieran los criterios de calidad científica y relevancia al objeto de estudio, arrojaron un total de ocho artículos (11).

Figura 1. Relajación de Jacobson. Tomado de: https://www.psicologia-online.com/la-relajación-muscular-progresiva-de-jacobsen-2329.htlm.

Figura 2. Mindfulness.

El análisis estadístico de los resultados encontrados a través de la d de Cohen demuestra que la intervención desde la ACT en pacientes con cáncer conlleva una mejoría entre media y alta de la sintomatología ansiosa y depresiva, el distrés emocional, la calidad de vida, la flexibilidad psicológica y las expectativas ante la vida (11).

Terapia física

La evidencia demuestra que la terapia física y el ejercicio disminuyen el dolor y mejora la fatiga en los pacientes con cáncer *(figura 3)*. Un gran número de pacientes con cáncer de mama las cuales les realizaron una mastectomía van a desarrollar una disfunción del hombro y dolor en la región torácica (5, 9, 10).

Se deberá de prescribir un programa de terapia física individualizado que incluya estiramiento de los músculos pectorales, fortalecimiento muscular, movilización del tejido blando, entrenamiento biomecánico y educación postural, los cuales son altamente efectivos en el manejo de dolor (5, 9, 10).

Días *et al.*, describieron la capacidad del entrenamiento físico para disminuir el dolor y la interferencia de éste en la vida diaria. El grupo experimental se sometió a 12 semanas de entrenamiento, incluidas tres sesiones de 60 minutos de ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia. También se incluían dos sesiones de entrenamiento de flexibilidad de 20 segundos y en series de tres repeticiones (5, 9, 10).

Por otra parte, el grupo control recibió únicamente el tratamiento hospitalario estándar. Tras las doce semanas del estudio, los pacientes en el grupo de estudio mostraron una disminución significativa en los puntos de dolor, la intensidad y la medida en que el dolor interfirió en su vida diaria. Hubo también un aumento en la captación máxima de oxígeno, flexibilidad y fuerza en ambas manos de los pacientes (5, 9, 10).

Figura 3. Terapia física.

No se observaron diferencias significativas en la fatiga o el Índice de Masa Corporal (IMC). Asimismo, se concluye que el entrenamiento combinado, que incluye ejercicios aeróbicos, de resistencia y de flexibilidad, puede ser una ayuda útil para el manejo del dolor en pacientes que reciben tratamiento para el cáncer (5, 9, 10).

Rojas Avendaño *et al.*, realizó una revisión sistemática, con búsqueda de artículos en las principales bases de datos biomédicas. Se incluyeron 16 estudios, de los cuales se obtuvieron datos concluyentes respecto a variables de prescripción del ejercicio a tenerse en cuenta en el momento de establecer un programa orientado a pacientes oncológicos, cuyos efectos se potencian con ejercicios aeróbicos y de resistencia muscular, desarrollados en un periodo mínimo de 3 sesiones semanales, durante 24 semanas (12).

La intensidad del ejercicio aeróbico y de resistencia se establece a partir de variables objetivas como la frecuencia cardíaca máxima y la resistencia máxima (12). Se destaca el ejercicio como una estrategia de intervención complementaria segura y beneficiosa que busca favorecer la mejoría de la condición clínica, emocional y participativa, bajo una condición supervisada por profesionales en fisioterapia (12).

El cáncer y sus tratamientos se encuentran asociados con un declive en la condición física, llevando a consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas. Los principales componentes del funcionamiento físico prequirúrgico, son la capacidad de resistencia aeróbica y la fuerza muscular, ambos elementos generalmente se encuentran disminuidos en estos pacientes, lo cual se establece como un factor predictor de complicaciones post operatorias y mayor riesgo de mortalidad (5, 9, 10).

En los últimos años, se han realizado diferentes estudios que evalúan la posibilidad de mejorar la función física previo al inicio del tratamiento, siendo parte fundamental de la prehabilitación como mecanismo para atenuar el estrés operatorio y así optimizar la recuperación post quirúrgica (5, 9, 10).

El acondicionamiento físico en la fase pre tratamiento consiste mayormente de ejercicios de resistencia para aumentar la masa muscular y la respuesta aeróbica y de fuerza, siendo este último el más efectivo durante dicho periodo, ya que es el que se ha asociado con mayor impacto positivo en la función cardiorrespiratoria (5, 9, 10).

Aunque la evidencia que apoya el uso de la preparación física para mejorar esta condición previo a que comience la fase de tratamiento hasta ahora ha sido escasa, cada vez existen más estudios que favorecen el ejercicio físico como parte esencial de la terapia en la prehabilitación (5, 9, 10).

Alguna de esta evidencia secunda que la capacidad funcional de los individuos es de extrema importancia para preservar la salud y que, por tanto, debe de optimizarse antes, después de la cirugía y durante cualquier tratamiento adicional, como lo suelen ser quimioterapia y/o radiación. De forma adicional, algunos estudios también señalan que la actividad física constituye un factor coadyuvante en el mejoramiento de la respuesta inmune del paciente (5, 9, 10).

Aún no existen protocolos específicos de ejercicio cardiovascular o resistencia en el periodo de prehabilitación en pacientes con cáncer. Sin embargo, a este respecto, la Sociedad Americana del Cáncer recientemente publicó sus guías, en las que sugieren realizar cada semana al menos 150 minutos de ejercicio con intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso o una combinación de ambos, además recomiendan incorporar entre 2 a 3 sesiones de entrenamiento de resistencia, incluyendo los grupos musculares más importantes (5, 9, 10).

Por otro lado, el entrenamiento se basa en el principio de sobrecarga, por lo tanto, a medida que el paciente se acostumbra a las demandas del ejercicio realizado, la intensidad deberá incrementarse progresivamente, siempre manteniendo un balance entre la intensidad/cantidad ideal de ejercicio (5, 9, 10).

Las prescripciones de ejercicio idealmente deben ser adaptadas al nivel basal de la condición física de cada persona, al procedimiento quirúrgico planificado y al estado de salud actual. En otras palabras, tiene que adecuarse a las necesidades individuales de cada paciente (5, 9, 10).

Es sumamente importante remarcar que en algunos individuos la actividad física estará completamente contraindicada o deberá modificarse en función de su estado de salud, ya que es conveniente mantener la seguridad en la población portadora de neoplasias (5, 9, 10).

Yoga

El Yoga es una forma de ejercicio físico no convencional, es una técnica milenaria que posee tres componentes esenciales: elongaciones musculares, ejercicios para el control de la respiración y meditación para una intervención mente - cuerpo (13).

Giménez *et al.*, realizaron una revisión en busca de evidencia en las bases de datos PubMed y SciELO, que apoyara al Yoga para su utilidad en beneficio de la salud de las personas (13).

Concluyeron que existe evidencia que apoya la utilidad del Yoga para el beneficio de la salud de las personas, aunque aún es limitada, debido a paradigmas aún existentes sobre conceptos de salud que limitan el diseño metodológico de muchos estudios referentes al tema (13).

Carson *et al.*, establecieron que la ejecución de intervenciones de Yoga, muestra en los sujetos una mejora en su estado general. El Yoga pretende desarrollar la conciencia plena a través de prácticas de meditación, ejercicios de respiración, entre otras actividades *(figura 4)* (9).

Figura 4. Yoga.

Durante el estudio, el grupo control recibe apoyo social con sesiones grupales centradas en la discusión de los problemas, el afrontamiento de éstos y temas que surgen en pacientes oncológicos. Tras estas sesiones no se nombra mejoría ni empeoramiento de los síntomas. El grupo experimental que recibe prácticas de yoga, mencionan una mejoría en el dolor, la fatiga y la angustia emocional que sienten en su proceso oncológico (9).

Masaje

En los pacientes con cáncer, se aplican técnicas específicas que, a priori, resultan más seguras ante la posible persistencia de células tumorales. Estas técnicas se pueden agrupar en dos tipos, que tienen diferentes objetivos: masaje oncológico y drenaje linfático manual (14).

El masaje oncológico se aplica realizando presiones muy suaves que actúan principalmente sobre la piel, sin llegar a desplazar la musculatura. Entre los efectos del masaje oncológico, cabe destacar, el alivio del dolor, mejora de la inmunidad, la calidad de vida y el sueño, reducción de ansiedad, depresión, fatiga, náuseas y estrés, aumento de serotonina y dopamina y disminución de los niveles de cortisol (14).

El drenaje linfático manual tiene como objetivo reducir el linfedema secundario a los tratamientos oncológicos como la cirugía o la radioterapia. El drenaje linfático manual tiene la capacidad de reabsorción de líquidos, aumento de la circulación linfática, reducción de la inflamación, alivio del dolor y acción relajante en los tejidos (14) *(tabla 1)*.

Tipos de masaje	Efectos
Masaje oncológico	• Alivio del dolor • Mejora de la inmunidad • Reduce la ansiedad, la depresión, la fatiga, las náuseas y el estrés • Mejora de calidad de vida y el sueño • Disminuye los niveles de cortisol • Aumenta la serotonima y la dopamina • Aumenta las células del sistema inmunitario
Drenaje linfático manual	• Reabsorbe los líquidos • Aumenta la circulación linfática • Reduce la inflamacion • Alivio del dolor • Acción relajante
Masoterapia	• Aumento de la permeabilidad de la piel • Mejora de la capacidad sensitiva • Aumento de la relajación • Mejora del sueño, el rendimiento y la circulación • Disminución de la tensión muscular y la Fcs • Mejora del estado de ánimo, el estrés y la ansiedad

Tabla 1. Tipos de masaje y su efecto. Modificado de: Rodriguez M. 2011.

Rodríguez Quintana realizó una búsqueda bibliográfica donde fueron incluidos ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se seleccionaron 27 artículos, 12 ECAs, 13 revisiones sistemáticas y 2 metaanálisis (14).

Se concluye que el masaje oncológico es demandado y es efectivo y el drenaje linfático es importante en el tratamiento de ciertos edemas, pero se requieren líneas de investigación que proporcionen datos acerca de la seguridad de estas técnicas en relación a los metabolismos desencadenados en el ambiente tumoral (14).

Otros estudios demuestran que produce reducción y control del dolor en un 66 % de los pacientes y es una medida efectiva para mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer en fase terminal y mejora la funcionalidad en los pacientes con dolor cervical (10).

También indican que entre el 11 % y 53 % de los pacientes lo han usado y actualmente se incluyen en guías de cuidado paliativo en pacientes con cáncer (10).

Medios físicos

Medios físicos que pueden contribuir en la modulación del dolor, reduciendo la necesidad de medicación analgésica y sus efectos secundarios (10).

Rodríguez *et al.*, realizaron una revisión sistemática con análisis descriptivo de cronología retrospectiva, con artículos científicos publicados en bases de datos indexadas entre enero del año 2009 a enero del año 2019. Se realizó una revisión sistemática bajo las consideraciones de la Colaboración Cochrane para la elaboración de estudios de revisión y meta-análisis (15).

En la evidencia recolectada, se encontró que una de las modalidades terapéuticas que se recomienda para el manejo del dolor del paciente oncológico, es la estimulación nerviosa eléctrica (TENS), ya que es un método no invasivo (15).

Por otro lado, el uso de la termoterapia y la crioterapia son eficaces para la disminución del dolor, a tolerancia de cada paciente (15).

Calor

El uso del calor en pacientes con cáncer es controvertido. Algunos autores refieren que este tipo de estímulos puede aumentar el crecimiento tumoral y la diseminación metastásica; otros investigadores refieren que hay disminución del dolor sin eventos adversos (10).

En las guías de práctica clínica Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) concluyeron que ante la ausencia de evidencia que contraindique claramente el uso de esta técnica, el calor superficial puede ser utilizado como método de control del dolor en pacientes oncológicos (10).

Precaución: pacientes con deterioro cognitivo o con alteración de la sensibilidad, técnicas de calor profundo (como ultrasonido, microondas) se utilizan con precaución en pacientes con cáncer activo, no aplicar directamente en sitios de cáncer o metástasis, o en zonas en donde se ha realizado radioterapia recientemente (10).

Crioterapia *(figura 5)*

Control de dolor, aunque de manera transitoria; no se han descrito eventos adversos en los pacientes con metástasis óseas, pero se debe tener precaución en el uso sobre áreas insensibles, irradiadas o con alteración de la circulación (10).

Figura 5. Termoterapia.

Efectos del Reiki respecto al dolor oncológico

El reiki aparece en la Nursing Interventions Classification (NIC) con el código 1520 y se define como una terapia de energía vibratoria que consiste en el uso de una secuencia de posiciones de manos y de símbolos para canalizar la fuerza universal con el fin de recargar, realinear y reequilibrar el campo de energía del ser humano *(figura 6)* (16).

Según diversos expertos, a nivel psicológico, el reiki presenta la facultad de eliminar bloqueos energéticos y aportar un incremento en el potencial de energía de las personas. El reiki les proporciona a las personas equilibrio y el regreso a su estado natural de salud, incrementando la sensación de bienestar, así como los sentimientos positivos. De esta manera, el reiki, al nutrir y fortalecer el sistema energético de las personas, favorece a que los sentimientos positivos sean realzados para aportar efectos psicológicos saludables (16).

Debido a ello, el reiki podría ser eficaz para tratar diversos problemas psicológicos como la depresión, el estrés o la ansiedad. Por otro lado, se pueden encontrar diversos estudios en los que se afirma que el reiki también es útil para mejorar trastornos somáticos. Por ejemplo, en el insomnio o fatiga, además de acelerar la curación, disminuir el dolor y aliviar los síntomas físicos (16).

Sin embargo, a su vez, se pueden encontrar estudios que afirman lo contrario, es decir, que no hay pruebas suficientes para asegurar que el reiki acelere la curación de las enfermedades somáticas o mejore los síntomas físicos (16).

Por tal motivo se llevó a cabo una revisión de la literatura basada en estudios científicos. El objetivo fue recopilar toda la información posible sobre la eficacia del reiki, concluyendo que no hay evidencia para afirmar que el reiki sea efectivo en el tratamiento de la ansiedad (16).

Figura 6. Reiki.

Debido al incremento actual del reiki, es fundamental difundir estos conocimientos a los profesionales sanitarios. De esta manera se podrán dar consejos y cuidados sanitarios acorde a las últimas evidencias científicas disponibles (16).

Tabatabaee *et al.*, efectuaron una revisión sistemática que incluía pacientes con diversos tipos de cáncer y sintomatología variada. Mediante esta revisión, determinaron que los pacientes que recibían contacto terapéutico reportaron beneficios subjetivos en relación con el estado de ánimo, el dolor, las náuseas, la ansiedad y la fatiga, entre otros (17).

Del mismo modo, Demir *et al.*, en su ECAC sobre los efectos del reiki, concluyeron que éste puede disminuir el dolor, la ansiedad y la fatiga en pacientes oncológicos (17).

Chirico *et al.*, también realizaron un ECAC con el mismo objetivo, pero centrándose en pacientes con cáncer de mama, y determinaron que las pacientes que recibieron tratamiento con reiki tuvieron una mejoría sensible del estado de ánimo, mientras que en el grupo de control (atención estándar) empeoró y la ansiedad tendió a aumentar (17).

Estudiando esta intervención en el mismo tipo de pacientes, Vanaki *et al.*, demostraron mediante un ECAC que el Reiki es efectivo para disminuir la duración, frecuencia e intensidad de las CINV (17).

Al contrario que todos los autores mencionados, existe un estudio piloto aleatorizado controlado que no apoya un efecto beneficioso del tratamiento sobre la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama sometidas a radioterapia (17).

En cuanto al uso de reiki como terapia de atención para el manejo de grupos de síntomas en niños y adolescentes con cáncer paliativo, los hallazgos del estudio que evalúa la terapia de reiki en esta población, muestra que todas las puntuaciones medias de las variables de resultado (dolor, ansiedad, frecuencia cardíaca y respiratoria) reducido después de dos sesiones de reiki ($p = .063$) (18).

Los hallazgos de esta revisión corroboran un estudio piloto publicado recientemente, realizado para probar la viabilidad y eficacia de reiki para proporcionar alivio del dolor en pacientes pediátricos sometidos a trasplantes de células madre hematopoyéticas (18).

Los autores del estudio piloto concluyeron que las enfermeras capacitadas en oncología pediátrica y adolescente pueden insertar reiki en la práctica clínica como instrumento válido para reducir el sufrimiento por cáncer en niños y adolescentes. Aun así, se enfatiza que los estudios sobre reiki son escasos hasta ahora, especialmente para la población de oncología pediátrica y adolescente como cuidados paliativos (18).

Musicoterapia

Peres *et al.*, demostraron que la música era una opción útil y agradable para disminuir el dolor oncológico. Los participantes del estudio mostraban incredulidad en relación a esta forma de terapia no farmacológica. Se aplicaron tres sesiones de música con canciones clásicas durante tres días (9).

Tras cada sesión, hubo una reducción en las puntuaciones de dolor en el 100 % de los casos. Los participantes informaron un alivio del dolor, un estado de relajación, una evocación de recuerdos personales y el olvido temporal de los problemas. Así pues, la contribución de este estudio fue señalar que la musicoterapia es otra opción válida y adyuvante para el control del dolor (9).

Jorge *et al.*, rubricaron que los experimentos musicales podían mejorar los efectos secundarios asociados al tratamiento del cáncer. Antes de las sesiones, los pacientes informaron de incredulidad en la música para el alivio de las náuseas y los vómitos. Todos los participantes del estudio eran consumidores de alguna droga quimioterápica (9).

Tras los encuentros musicales, hubo una reducción de la frecuencia cardíaca en el 77 % de los participantes, y una disminución de la frecuencia respiratoria en la mayoría de los pacientes. No hubo cambios significativos en la tensión arterial de la mayoría de los pacientes. Finalmente, se comprobó que hubo una reducción significativa de las náuseas y los vómitos en el 100 % de los participantes después de las experiencias musicales (9).

Araujo *et al.*, destacaron que las ocho reuniones musicales realizadas en el estudio intensificaron el proceso de relajación del individuo, fomentando la exposición de percepciones, emociones y sentimiento ocultos. Durante el estudio se otorga plena participación a los pacientes en la elección del repertorio de canciones, y así aumentar su autoestima (9).

La música les proporcionó comodidad y bienestar de forma completa. Se concluyó que los encuentros musicales son un recurso del cuidado de enfermería en el paciente oncológico, que inspira vida a los días del paciente, ofreciéndole sensación de cuidado y otorgándole significado a su existir en el mundo (9).

También mejora la relación del cuidador con el enfermo y ayuda a potenciar las ganas de luchar y enfrentarse a la enfermedad. Por todo ello, la música es un recurso terapéutico innovador que puede contribuir a la ciencia, los fundamentos y el arte de la enfermería (9).

Acupuntura

Una revisión sistemática y analítica de tipo cuantitativa, sometida a selección critica, utilizando el sistema de evaluación Grade para la identificación del grado de evidencia, hallados en las siguientes bases de datos: PubMed, Sciencedirect, Scielo, Wiley Online Library, Elsevier, Epistemonikos. De los 10 artículos revisados sistemáticamente el 70 % (n= 7/10) son revisiones Sistemático, el 20 % (n= 2/10) son revisiones sistemáticas – metaanálisis y el 10 % (n= 1/10) es metaanálisis (19).

Los datos obtenidos de las revisiones sistemática, revisiones sistemáticas –metaanálisis y metaanálisis los resultados del estudio son que estas proceden de los siguientes países: China (50 %), seguida de Alemania (20 %), Reino Unido (10 %) y EEUU (20 %) (19).

En relación a las evidencias de los estudios encontradas, el 70 % (n=7/10) señalan sobre la eficacia de la acupuntura como un tratamiento adyuvante o complementario apropiado para la mejora de los síntomas del paciente con cáncer, mejorando la calidad de vida en los pacientes oncológicos, de la cual no se evidencia efectos adversos, pero se necesitan estudios adicionales para generar más fiabilidad en su uso (19).

López junior *et al.*, realizó una revisión sistemática guiada por el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. La búsqueda de artículos en las bases de datos Medline, ISI Web of Knowledge, central Cochrane y PsycINFO, así como la búsqueda manual, selección de estudios, extracción de datos y evaluación metodológica con la utilización de la herramienta Riesgo de Sesgo de Cochrane se realizaron por dos revisores de forma independiente (20).

Y los dos estudios que evaluaron el uso de la acupuntura como terapia complementaria mostraron resultados divergentes, razón por la cual se requiere de más investigación para dilucidar tales hallazgos (20).

Conclusiones

La terapia no medicamentosa, es variada y no todas con el nivel de evidencia deseado, pero evidentemente constituyen una alternativa terapéutica que favorece la eficacia del tratamiento medicamentoso.

Bibliografía

1. Pastor A, Amorós A, Valero R. Rotación a Metadona en domicilio como alternativa en dolor refractario oncológico. Hosp Domic [Internet]. el 31 de octubre de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];3(4):279–88. Disponible en: https://www.revistahad.eu/index.php/revistahad/article/view/81
2. Marrero L. Manejo del dolor oncológico. 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15982
3. Juvier Y, Ortega Y, Rodríguez L, Cuevas O, Ruiz D. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico Treatment of pain in oncological patients. 2019;10.
4. León M, Santa J, Martínez S, Ibatá L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico (revisión de la literatura). Rev Mex Anestesiol [Internet]. el 30 de enero de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];42(1):45–55. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84793
5. Castro S, Porras A. Prehabilitación en pacientes oncológicos: Una revisión bibliográfica. Rev Cienc Salud Integrando Conoc [Internet]. el 1 de junio de 2020 [citado el 1 de septiembre de 2021];4(3):ág. 12-17. Disponible en: http://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/view/152
6. Quezada A. Efectividad de las intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor en niños y adolescentes con cáncer. Revisión documental. Repos Tesis - UNMSM [Internet]. 2020 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/16594
7. Carregal A. Dolor asociado al proceso oncológico: viejos conceptos y nuevos horizontes. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2021 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://gestoreditorial.resed.es/fichaArticulo.aspx?iarf=225687760-749236419278
8. González G, Barrios M, Hernández E. Mindfulness como tratamiento coadyuvante del dolor. FMC - Form Médica Contin En Aten Primaria [Internet]. el 1 de agosto de 2020 [citado el 1 de septiembre de 2021];27(7):349–52. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207220300839

9. Moyano C. Intervenciones enfermeras a pacientes con dolor oncológico tratados con terapias alternativas. junio de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/137361
10. Quesada J, Uclés V. Rehabilitación oncológica del adulto mayor. Rev Clínica Esc Med UCR-HSJD [Internet]. el 31 de enero de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];8(6). Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/clinica/article/view/36133
11. García A, Tamayo J. Revisión sistemática sobre la eficacia de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en el tratamiento psicológico de pacientes con cáncer. Psicooncología [Internet]. el 1 de enero de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021];16(1):101–25. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/63651
12. Rojas F, Sepúlveda N, González A, Carvajal N. Prescripción del ejercicio en el paciente oncológico. Revisión sistemática. Fisioterapia [Internet]. el 1 de julio de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021];43(4):218–29. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563820301395
13. Giménez G, Olguin G, Almirón M. Yoga: health benefits. A literature review. An Fac Cienc Médicas Asunción [Internet]. el 30 de agosto de 2020 [citado el 21 de septiembre de 2021];53(2):137–44. Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1816-89492020000200137&lng=es&nrm=iso&tlng=es
14. Rodriguez M. Eficacia y seguridad de la masoterapia en pacientes oncológicos. Revisión bibliográfica. 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/22717
15. Rodríguez J. Rol de la fisioterapia en los cuidados paliativos. Mov Científico [Internet]. 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021];13(2):55–66. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7440064
16. Pizarro S. ¿Reiki para reducir la ansiedad? Rev Esp Enferm Salud Ment [Internet]. el 10 de abril de 2020 [citado el 21 de septiembre de 2021];(10). Disponible en: http://www.reesme.com/index.php/REESM-AEESME/article/view/79
17. Daryan S. Influencia de las terapias complementarias sobre la sintomatología de los procesos oncológicos. el 31 de mayo de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/182936
18. Lopes L, Urbano I, Schuab C, Pessanha R, Rosa G, Lima R. Efectividad de las terapias complementarias para el manejo de los grupos de síntomas en los cuidados paliativos en oncopediatría: revisión sistemática. Rev Esc Enferm USP [Internet]. el 19 de mayo de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021];55. Disponible en: http://www.scielo.br/j/reeusp/a/rCRgxxQpmcfnFhDwxHxpH5K/abstract/?format=html&lang=es
19. Arevalo S, Fabián J. Eficacia de la acupuntura para mejorar los síntomas del paciente con cáncer. Univ Priv Norbert Wien [Internet]. el 3 de noviembre de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/3450
20. Lopes L, Rosa G, Pessanha R, Schuab S, Nunes K, Amorim M. Eficacia de las terapias complementarias en el manejo del dolor oncológico en los cuidados paliativos: revisión sistemática. Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. el 30 de septiembre de 2020 [citado el 21 de septiembre de 2021];28. Disponible en: http://www.scielo.br/j/rlae/a/tPpNcgJy37RC8mdxtVysP/?format=html&lang=es
21. Cobbe & Kennedy, Physical Function in Hospice Patients and Physiotherapy Interventions: A Profile of Hospice Physiotherapy, 2012)) (Cobbe, Nugent, & Slattery, A profile of hospice-at-home physiotherapy for community-dwelling palliative care patients., 2013.